

7 - 02- LA PATHOLOGIE DES GLANDES SALIVAIRES - Pr. ABOUCHADI

Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la pathologie des glandes salivaires. C'est une pathologie qui est polymorphe, d'où l'intérêt de cette question. Le but de notre cours, c'est d'être capable de diagnostiquer une pathologie qui va atteindre ces glandes.

Ce sont des glandes exocrines, dont la fonction principale est la production de la salive. Ces glandes sont sujettes à un certain nombre de processus pathologiques, notamment tumorales, inflammatoires et aussi infectieuses. Au final, l'étudiant doit être capable de diagnostiquer une pathologie tumorale, infectieuse, litiésique, immunologique des glandes salivaires.

Comme je l'ai dit, l'objectif de ce cours, c'est d'être capable de diagnostiquer les différentes pathologies qui atteignent les glandes salivaires. Pour rappel, les glandes salivaires sont disposées en paire pour les glandes salivaires principales, notamment les glandes parotides, qui se situent dans une région en avant des pavillons de l'oreille, en dehors des muscles massétéres. Les glandes sous-mandibulaires ou submandibulaires, qui se situent sous la mandibule.

Les glandes sublinguales, comme leur nom l'indique, sont situées sous la langue. Ce sont des glandes qui sont en paire, symétriques, dont la fonction principale est de produire de la salive. La muqueuse de la cavité buccale est tapissée par des glandes salivaires accessoires.

Comme nous le voyons sur ce schéma, la glande parotide, qui se situe sur la région parocidomassétéline, la glande submandibulaire, qui se situe sous la mandibule. Nous rappelons l'histologie de la glande salivaire, qui est constituée essentiellement par des acinides. Les acinides sont composés de cellules serreuses et de cellules muqueuses.

Les cellules serreuses vont sécréter un liquide filant, riche en amylase. Les cellules muqueuses, un liquide plus ou moins épais, qui va avoir un rôle pour solidariser le bol alimentaire. Et il y a aussi une possibilité d'avoir un acinus mixte, où il y a une sécrétion de salive serreuse et de salive muqueuse.

Sur une copiste logique du tissu parotidien, on remarque en 1, 2 et 3. En 1, les acinides. En 2, les canaux excréteurs. On voit que la lumière commence à grandir.

C'est là où se collecte la salive sécrétée par l'acinide, plutôt par l'acinus. Et les cellules adipeuses, qui constituent un tissu de soutien pour l'ensemble de ces éléments histologiques. Nous rappelons que la salive joue un rôle important dans la déglutition, la digestion, la protection dentaire et dans l'articulation de la parole.

Pour la déglutition, c'est celle qui permet de mouler le bol alimentaire. La digestion par la sécrétion d'enzymes, telles la mylase, la lipase, permet un premier temps de digestion des

aliments au niveau de la cavité buccale. Par la production d'immunoglobulines sécrétoires, il y a la protection de la cavité buccale et notamment dentaire.

Et aussi, cette fluidification continue de la langue permet une articulation de la parole. Sur le plan pathologique, plusieurs types de pathologies peuvent atteindre ces glandes salivaires et ces canaux excrétoires. La tumeur va être caractérisée par son siège unilatéral.

Les autres processus, que ce soit infectieux ou inflammatoire, peuvent être bilatéral et diffus. Et on a aussi des pathologies qui vont atteindre les canaux. C'est pour cela qu'on va appeler les pathologies qui atteignent les glandes, que ce soit de façon inflammatoire, on les appelle les sialoses.

Les pathologies infectieuses qui atteignent les glandes sécrétoires salivaires, on les appelle les sialites. Donc sialose et sialite. Pour les pathologies qui vont atteindre les canaux excrétoires, on les appelle les colites.

Les colites. Sialodocolites. On peut avoir des sialodocolites en association d'une atteinte glandulaire et canalaire.

Donc, comme je vous l'ai dit, les sialoses correspondent à des atteintes inflammatoires des glandes salivaires. Elles sont en ordre général, ce qui fait qu'elles sont caractérisées par la bilatéralité des lésions, par des lésions qui sont diffuses, qui sont en général chroniques. Les sialites, elles ont un caractère aigu, inflammatoire.

Elles aussi peuvent être bilatérales, mais peuvent être aussi unilatérales. Les sialoses, elles sont bilatérales, diffuses, chroniques. Elles ont un caractère bilatéral, diffus, chronique.

Elles sont représentées essentiellement par la sarcoïdose, une pathologie inflammatoire qui va atteindre aussi les glandes salivaires parce qu'elle atteint tout le corps. Vous vous rappelez de la sarcoïdose pulmonaire, mais il y a aussi la sarcoïdose des glandes salivaires. C'est pour cela qu'on demande le plus souvent, dans le cadre d'un bilan de sarcoïdose, de rechercher sur des biopsies des glandes salivaires.

C'est l'accessoire, la localisation de certains processus inflammatoires histologiques au niveau des glandes salivaires. Mais dans la forme céphalique, je dirais céphalique de la sarcoïdose, on peut avoir le syndrome d'Erfurt qui va associer une parotidose, une tumefaction des parotides, une sonde bilatérale, une paralysie faciale périphérique et une atteinte oculaire type uveïte. On a aussi dans les sialoses le syndrome de Gougerot-Sogren qui est caractérisé par un HLA-DR3 positif.

La biopsie des glandes salivaires accessoires va montrer une raréfaction de ces glandes, mais aussi des dépôts de certains immunoglobulins qui sont marqués par les immunohistochimiques et l'association fréquente à ce syndrome de Gougerot d'un lymphome de Malte. Aussi on a la

mylose qui peut aussi constituer une sialose à caractère bilatéral, diffus et chronique. En ce qui concerne les atteintes infectieuses, les sialites, elles ont un caractère inflammatoire aiguë, elles peuvent être bilatérales ou unilatérales.

Bilatérales, on peut avoir une atteinte virale type oréon ou coxaciavirus, c'est pour cela que les enfants vont avoir une parotide omégalie ou une augmentation homogène de toutes les glandes salivaires. Des atteintes par coxaciavirus aussi, mais aussi des atteintes bactériennes récidivantes en général sont liées à des malformations congénitales des canaux excréteurs qui vont entraîner une infection à répétition au niveau de la glande salivaire, notamment la parotide, qu'on appelle la parotide bactérienne de l'enfant. Une atteinte unilatérale qui peut se voir chez le sujet âgé dans un cadre de déshydratation, de sepsis sévère, de dénutrition, d'une mauvaise hygiène buccodentaire, un traumatisme d'appareil dentaire qui va entraîner une obstruction du canal excréteur et donc développer par phénomène rétrograde une parotidisme bactérienne.

Une forme particulière des sialites unilatérales, on a la lithie salivaire qui aussi peut constituer un accident infectieux assez notable. Sur le plan diagnostique, l'examen des glandes salivaires doit être un examen qui devra être intégré dans l'examen général. Un examen de tout le corps où il n'y a pas un examen de la cavité buccale et notamment de la face serait incomplet, notamment que ces glandes salivaires vont être intéressées par un certain nombre de processus, de maladies générales qui normalement sont cherchées systématiquement.

L'examen doit se faire de façon méthodique, de façon comparative, rechercher l'aspect normal des glandes parotides. Normalement, elles ne sont pas palpables. Si elles commencent à être palpables, c'est-à-dire qu'elles sont augmentées de volume.

Si elles sont homogènes, si elles sont élastiques, si elles sont dures, si elles sont douloureuses, si elles sont chaudes, inflammatoires. Aussi, il faut palper les différentes glandes submandibulaires. Donc, à savoir que la parotide est la glande salivaire la plus touchée par ces phénomènes, cette pathologie salivaire.

Si la lithiase salivaire est la plus fréquente au niveau de la glande submandibulaire, la parotide reste la glande la plus touchée ou bien les manifestants cliniques sont les plus caractéristiques dans cette pathologie salivaire. Donc, il faut reconnaître le siège parotidien d'une tuméfaction, qui normalement va se faire sans problème. Elle se projette typiquement dans la région rétro-mandibulaire, entre l'abouchement tant en avant et les muscles sternocleurodomastoidiens, et le conduit excréteur en arrière, au-dessus de l'angle mandibulaire.

En général, les parotides ne sont pas palpées. Si elles ne sont pas palpées, c'est-à-dire qu'elles sont augmentées de volume. Et quand ce volume est très important, il va finir par soulever le lobule de l'oreille.

Quelquefois, la projection est inhabituelle au niveau de la joue, si la tuméfaction siège dans le prolongement antérieur de la glande parotide. Au niveau de l'oropharynx, en-dedans du pilier

antérieur, c'est pour cela qu'à chaque fois qu'on fait un examen des glandes salivaires, il faudra faire un palpébis digital, un doigt dans la bouche, au niveau de la région aminitalienne, et un doigt sur la région jugale, en externe, pour rechercher ce fameux prolongement profond. Des fois, la thuméfaction peut se manifester à l'intérieur de la bouche.

On a une thuméfaction ondo-bucale. Une thuméfaction latérocervicale, il faut toujours chercher les thuméfactions submandibulaires, parce que le processus inflammatoire, il peut toucher les glandes parotides, les glandes submandibulaires, mais aussi les glandes sublinguales, les glandes sublinguales. On demande aux patients d'ouvrir la bouche.

Ils soulèvent la langue, et on va voir un relief du canal excréteur de Vartan de la glande submandibulaire, mais aussi des petits reliefs de paréthode du frein inférieur de la langue. Des fois, ils s'enjaunâtrent. Ils sont surmontés par une ouverture d'un ostium des glandes sublinguales, qu'on appelle les petites carencules, les grandes carencules, plus ou moins en arrière et en externe, qui correspondent à l'ostium du canal de Vartan.

Les caractères de la tumeur doivent être précisés. Son mode d'apparition, son évolution, si elle est brutale, rapide, lente, progressive, pour différencier entre les phénomènes aigus d'installation rapide et les phénomènes chroniques. Elle doit être unie ou bilatérale, un aspect inflammatoire, l'état de la peau au regard, si elle est peau d'orange, rouge, douloureuse, une paralysie faciale périphérique, comme dans le cadre du syndrome d'Erfurt, dans les sarcoïdoses, la localisation de glandes salivaires.

La consistance, est-ce qu'elle est dure, inhomogène, fluctuante, élastique, indolente ? Et aussi, il faut toujours terminer l'examen par la pression au niveau de la glande, que ce soit parotidienne ou submandibulaire, pour voir l'écoulement salivaire. Est-ce que c'est une salivité normale, translucide ? Est-ce qu'elle est abondante, absente, dans le cadre de syndrome sec, l'issue de peu, et des fois même, écoulement de sang, dans le cadre de pathologies tumorales malignes ? L'examen se termine par une recherche d'adnéopathie. Recherche d'adnéopathie, avec l'atteinte d'une herbe faciale à paralyser, minime soit-elle, doit également être un juste réflexe, qui nous oriente vers une pathologie tumorale.

Toute paralysie faciale périphérique et adnéopathie, donc il faudra compléter le cortège des signes cliniques qui nous vont nous orienter vers une pathologie tumorale maligne, c'est-à-dire l'altération d'état général, l'infiltration, le caractère dur de la masse. Donc il faudra être très vigilant quand on trouve une adnéopathie associée à une atteinte d'une herbe faciale, donc on est devant une pathologie tumorale maligne des glandes salivaires. Quelle imagerie ? Demandez dans le cadre de la pathologie salivaire.

On dispose de plusieurs examens à des sensibilités différentes et donc l'examen des glandes salivaires peut recourir à l'échographie. L'échographie qui a une valeur localisatrice, permet de localiser un processus tumoral au niveau des glandes salivaires et donc elle permet de poser des

fois, dans quelques cas, un diagnostic positif entre une tumeur, un kyste, le contenu, est-ce qu'il est liquidien, est-ce qu'il est tissulaire. Mais il reste quand même un examen qui est dépendant du praticien.

L'échographie sous-mandibulaire, elle peut aussi mettre en évidence un calcul avec l'image en cône d'ombre, avec une image hypo-écogène qui correspond à un calcul qui obstruit le canal excréteur. La sciélographie, comme on le voit sur cette image, qui correspond à l'opacification du canal excréteur de la glande sous-mandibulaire. La TDM, elle permet encore plus de précision quant à l'examen des parties molles par rapport à la sciélographie.

Mais quand elle est associée à l'opacification du canal excréteur, elle permet de faire une sciélo-TDM qui permet de nous renseigner sur la fonctionnalité de la glande salivaire, que ce soit parotidienne ou submandibulaire. L'IRM, elle donne encore plus de précision sur les tissus, sur les parties molles. Elle permet de différencier un phénomène inflammatoire d'un processus tumoral.

La panoramique dentaire ou l'orthopantomogramme est un examen de débrouillage avec l'incidence du mordue qui permet des fois de localiser un élément radio-opaque qui correspond à un calcul qui va nous aider à mieux le palper, à le situer, est-ce qu'il est intra-glandulaire, intraparenchymateux ou bien dans le canal excréteur, vraiment en antérieur et qui va conditionner notre prise en charge thérapeutique. À côté de l'imagerie, quel bilan biologique demander ? L' NFS, elle permet de nous orienter vers les problèmes hématopoétiques, notamment les lymphocytes. Le myélogramme sanguin, des fois on peut diagnostiquer un diabète.

Les diabétiques peuvent faire des parotidomégalies, des augmentations de volume des glandes salivaires, parotidales, mais aussi de toutes les autres glandes. L'augmentation de la myélasémie peut avoir un caractère orientateur pour rechercher d'éventuels processus inflammatoires au niveau des glandes salivaires. La sérologie, syphilis et du VIH pour détecter d'éventuelles hyperplasies parotidiennes.

L'IDR pour rechercher une localisation tuberculeuse au niveau des glandes salivaires. Le dosage de l'activité plasmatique de l'enzyme de conversion, notamment dans le cadre de la sarcoïdose. Mais aussi la recherche d'auto-anticorps lorsqu'on est devant un contexte de maladie générale auto-immune.

La biopsie des glandes salivaires accessoires peut être d'une grande utilité pour diagnostiquer un syndrome sec ou bien une pathologie inflammatoire générale après étude immunohistochimique. La cytologie de la salive permet de rechercher une atteinte bactérienne. La parotidoptomie exploratrice avec examen anatomopathologique dans le cadre de pathologie tumorale ou un examen histologique s'impose.

Il faut savoir qu'une biopsie au niveau de la parotide n'est pas recommandable et même je pourrais dire n'a pas d'indication. Pourquoi ? Parce que l'exploration de la parotide doit passer

obligatoirement par une dissection du nerf facial pour bien sécuriser le geste pour ne pas entraîner de paralysie faciale et donc une biopsie comme ça à l'aveugle n'a pas d'indication. Donc on va devoir enlever soit la parotide totalement, soit une partie de la parotide mais après dissection du nerf facial, ce qu'on appelle parotidoptomie exploratrice.

Exploratrice parce qu'on explore, on dissèque le nerf facial avant d'enlever la partie qui nous intéresse. Pour pouvoir l'analyser et donc diagnostiquer une pathologie tumorale soit bénigne ou maligne ou bien un processus inflammatoire sur lequel nous avons des doutes. Ce qui nous ramène à avoir plusieurs étiologies à discuter.

Donc après l'examen clinique, après l'exploration par imagerie, après l'exploration par bilan biologique, nous nous retrouvons devant un cas de tuméfaction de glandes salivaires principales qui a soit un caractère non inflammatoire, qui est d'installation chronique, soit un caractère inflammatoire. Elle est soit unilatérale dans le cadre d'une tumeur, bilatérale dans le cadre d'un hémocystème. Un caractère inflammatoire qui est soit unilatérale, soit bilatérale dans le cadre des infections bactériennes, ou bien infections virales.

Dans le cadre de la pathologie inflammatoire, non inflammatoire plutôt, de caractère unilatérale, les tumeurs restent le chef de file de cette pathologie non inflammatoire et unilatérale. Les tuméfactions non inflammatoires et unilatérales, elles sont en grande majorité des tumeurs de la glande parotide et évoluent sous forme de nodules de la loge parotidienne. Les tumeurs extrasalivaires et les pseudotumeurs sont exceptionnels.

La parotide est la plus touchée. Le diagnostic positif repose sur une tuméfaction de la loge parotidienne en inflammatoire unilatéral. Elles peuvent être soit des tumeurs primitives, soit des tumeurs ganglionnaires, soit des tumeurs extraondulaires, soit des kystes.

Ce qu'on appelle les pseudotumeurs. Les tumeurs sont classés soit en tumeurs épithéliales, soit en tumeurs hématologiques ou conjonctives. Tumeurs épithéliales, tumeurs non épithéliales.

Les tumeurs épithéliales dominées par l'adénome pléomorphe. Les tumeurs dans 80% des tumeurs bénines. Les tumeurs épithéliales dans 80% des tumeurs bénines, dominées par l'adénome pléomorphe.

Les tumeurs malignes sont dominées par l'adénocarcinome, le carcinome adénoïdostictique. Les autres processus tumoraux hématologiques, soit bénins ou malignes, vont se localiser au niveau des glandes salivaires. Dans le cadre de la pathologie bénigne, les infiltrants lymphoïdes pré-lymphomateux, qui se voient dans le cadre de l'HIV, et dans le cadre du syndrome de Gougerot.

Ce syndrome de Gougerot qui peut évoluer vers un lymphome. Les pathologies bénignes, telles que le lymphomaloïdoginien B de type malin. Les tumeurs conjonctives, on a les tumeurs bénignes, hémangiome, hvanome, et les malignes, sont les sarcomes.

Les tumeurs tumorales, avec comme chef de file l'adénome pléomorphe, ou tumeur mixte de la parotide. Il faut retenir que c'est une tumeur qui est fréquente. C'est une tumeur qui est fréquente chez la femme.

Elle est d'évolution lente, de diagnostic facile, et le traitement passe par un traitement chirurgical. C'est tout ce qu'il faut retenir, c'est une tumeur qui apparaît sous forme d'une boule, au niveau de l'air parotidien, qui a une consistance élastique, qui est indolore, et il n'y a pas de signe de maladie. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de parésie faciale, il n'y a pas d'adénopathie.

Il n'y a pas de signes d'infiltration cutanée, il n'y a pas de signes inflammatoires, il n'y a rien. C'est une simple boule. Mais ceci dit, il faut toujours être vigilant.

Le traitement passe par une parotidectomie exploratrice, pour faire un diagnostic positif à l'examen histologique pour trancher. C'est-à-dire que l'examen clinique nous donne des présomptions sur le diagnostic, mais la certitude se fait par l'examen histologique. Donc, il faudra faire des examens complémentaires, qui vont confirmer la nature intraparotidienne de la tumeur, que ce soit une échographie ou une TDM.

Mais l'IRM, c'est elle qui permet d'avoir plus de précisions sur les caractéristiques de cette tumeur. La cytoponction n'a pas beaucoup d'apport dans cette pathologie, parce qu'elle n'a de valeur que si elle est positive, si elle n'existe, ça ne veut rien dire. Donc le traitement, il est chirurgical.

C'est une parotidectomie avec conservation du nerf facial. La survie doit être prolongée dans ces tumeurs, pourquoi ? Parce qu'il y a risque de récurrence. Les récurrences peuvent se faire de façon métastatique à plusieurs foyers.

À côté d'unompléomorphe, comme je vous ai dit, c'est une tumeur qui est unilatérale, et qui siège surtout au niveau de la parotide, et qui est plus fréquentée à la femme. On a le cystoadénolymphome papillaire ou tumeur de Warthin, qui atteint le pôle inférieur de la parotide. Il est caractérisé par la fréquence de sa survenue chez l'homme entre 40 et 60 ans, et il est parfois bilatéral.

Des fois, il pose un diagnostic différentiel avec le lymphome, par son caractère bilatéral. Donc le diagnostic est confirmé à la parotidectomie exploratrice, et le traitement aussi consiste en cette parotidectomie partielle, avec conservation du nerf facial, et le pronostic est bénin. Il y a aussi les adénomes monomorphes et les adénomes oxyphiles.

Ce polymorphisme histologique des tumeurs dépend du polymorphisme histologique de ces glandes salivaires. À côté de ces tumeurs épithéliales, on a les tumeurs épithéliales malignes, à côté des tumeurs épithéliales bénignes, il y a les tumeurs épithéliales malignes, qui sont dominées par l'adénocarcinome, qui est une tumeur de très mauvais pronostic, qui atteint le sujet à tout âge. Elle peut être primitive, ou bien une tumeur secondaire.

Elle augmente rapidement de volume, elle est infiltrante, elle est douloureuse, elle s'accompagne d'adénopathie, et d'une paralysie faciale. Donc retenir que les signes de malignité sont l'augmentation rapide du volume, l'infiltration, la douleur, l'adénopathie, et la paralysie faciale. Donc il y a entre une tumeur à contour mal défini, et le pronostic de cette tumeur reste très mauvais, malgré le traitement chirurgical, l'évidement ganglionnaire, et la radiothérapie.

Donc c'est une tumeur qui nécessite un diagnostic très précoce, mais quand même qui garde un très mauvais pronostic. Il y a aussi le carcinome adénoïde kystique, ou synandrome, qui constitue 10% des tumeurs malignes de toutes les glandes salivaires. Il atteint les personnes à tout âge.

Il est plus fréquent chez la femme. Le diagnostic repose sur l'examen qui montre une tumeur qui séjourne souvent au niveau de la parotide, qui sont dures, de croissance rapide, avec une douleur spontanée et à la palpation. Donc la gravité de ce carcinome, c'est le potentiel à la récurrence, et la métastase par l'intermédiaire des gaines des nerfs.

Donc il donne surtout des métastases pulmonaires et osseuses. Donc le traitement passe par une parotide ectomie conservatrice du nerf facial, suivie d'une radiothérapie. À côté de l'adénocarcinome et du carcinome adénoïde kystique, on a les tumeurs mycopédermoïdes et les tumeurs à cellules acineuses.

Donc il y a aussi d'autres carcinomes, notamment les carcinomes épidermoïdes indifférenciés, qui peuvent être soit de localisation primitive, ou bien des métastases des cancers de la région. Donc d'où l'intérêt de poser la question, est-ce que le patient n'a jamais eu, comme antécédent, un carcinome épidermoïde cutané opéré au niveau de la région palpébrale, jugale, qui, avec le temps, aurait métastasé au niveau de la région parotidienne. Ce polymorphisme tumoral, il note bien du polymorphisme histologique qui existe au niveau de ses glandes salivaires.

Donc à côté de ces tumeurs épithéliales, on a les tumeurs non épithéliales. Les tumeurs non épithéliales sont multiples, mais peu fréquentes. Donc on a les tumeurs vraies, malignes, qui sont les métastases ganglionnaires d'un carcinome, curchevelu, carcinome épidermoïde mélanome, métastases ganglionnaires d'un carcinome.

Ici, les tumeurs bénignes d'origine conjonctive nerveuse, neurinome, vasculaire, hémangiome, graisseuse, lipome intraparotidien. On a aussi les pseudotumeurs, qui sont consécutifs à certains parotides chroniques spécifiques, notamment en syphilitique, qui donne un aspect pseudotumoral. Tuberculeuses, qui vont donner des aspects pseudotumoraux, avec aussi des adénopathies tuberculeuses qui évoluent à l'intérieur de la parotide.

Les kystes canaux, qui sont souvent des séquelles d'obstruction de canaux qui vont se développer à l'intérieur du parenchyme. Ce sont des kystes salivaires qui vont retenir de la salive et qui peuvent, par moments, se manifester par des complications infectieuses. À côté de ces

pseudotumeurs, il y a aussi la pathologie parotidienne dans le cadre de la séropositivité HIV.

On constate une augmentation du volume de la parotide, dans laquelle s'individualisent des formations kystiques. Cette atteinte est souvent bilatérale. Elle est indolore, mais esthétiquement gênante.

Surtout quand le patient est amaigri. La pathologie est dominée par des lésions lymphoépithéliales bénignes, ce qu'on appelle les HLK. Le problème est, là aussi, d'éliminer une tumeur maligne.

L'hyperplasie d'un foïde kystique réagisse le plus souvent sous traitement antiviral. Sa persistance peut faire discuter une parotidectomie superficielle, à titre morphologique. Les tumeurs parotidiennes chez l'enfant, rares avant l'âge de 20 ans, mais en général sont de très mauvais pronostics.

Surtout lorsqu'elles sont malignes. Heureusement que les tumeurs vasculaires sont les plus fréquentes, les hémangiomes. Rarement on retrouve des anéantimores.

Mais 50% des tumeurs malignes sont faites de carcinoïdes myco-épidermides. Ils sont de très mauvais pronostics. Les tumeurs sont un inflammatoire unilatéral en pathologie tumoral.

Donc il faut retenir que ces tumeurs non inflammatoires, qui ne correspondent pas à un processus inflammatoire mais à un processus tumoral, elles ont une caractéristique, elles sont unilatérales. Le plus souvent unilatérales. Donc il faut distinguer les signes de b nignit  des signes de malignit , qu'il faudra retenir.

Les signes de b nignit , c'est la tumeur qui est isol e, asymptomatique, aspergulier et mobile. Et bien s r qu'elle  volue dans un  tat de conservation d' tat g n ral. Les signes de malignit  sont les ad nopathies, la paralysie faciale, p riph rique.

C'est une l sion qui est en g n ral fixe. Elle peut s'accompagner d'un trismus, parce que le processus est tellement  volu  qu'il a infiltr  l'appareil masticateur. Et elle est douloureuse.

Donc il faut bien retenir ces signes pour faire un diagnostic diff rentiel entre tumeur b nigne et tumeur maligne. On a parl  de la tumefaction des glands salivaires principales non inflammatoires, unilat rales, tumeurs. On va parler apr s de la tumefaction non inflammatoire bilat rale qui correspond aux maladies de syst me Cialos et les tumeurs de Varta.

Donc ces Cialos sont domin s par la sorte que vous devez soumettre de Pesnier-Bach-Schumann, caract ris  par une hypertrophie paroxydienne bilat rale, un dolore d'installation rapide, qui peut s'accompagner d'une uve de, une paralysie faciale p riph rique, et qui va constituer au complet un syndrome de Erfurt. Il est typique de la sarco dose. Il s'accompagne d'autres manifestants, d'amaputan es, osseuses, pulmonaires, ganglionaires, visc rales.

Le diagnostic est suspecté devant la négativité de l'IDR et confirmé par le dosage de l'activité plasmatique de l'enzyme de conversion et l'examen histologique. L'évolution de cette atteinte paroxysdienne est souvent rapidement favorable. A côté de la sarcoïdose, on a les syndromes secs.

Ils associent un gonflement paroxysdien bilatéral diffus, une sécheresse oculaire, xérophthalmie, et buccale xérostomie, et des acialis. C'est une diminution, une hypo, une acialis, ou une disparition de la sécrétion salivaire, avec les manifestations de cette sécheresse, qui peut être une buccale, qui va entraîner une xérostomie avec un retentissement sur l'agencif paroxysdite en rapport avec la diminution de l'ADAC, mauvaise haleine, mauvaise hygiène buccodentaire, carie dentaire. Mais ces sécrétions salivaires, elles sont souvent associées avec une diminution de la sécrétion lacrymale.

Et on peut avoir aussi des manifestations oculaires, notamment xérophthalmie, sécheresse oculaire. Les syndromes secs sont dominés par le syndrome de Gougeron sur graines. Le plus caractéristique, il est isolé ou associé à d'autres manifestations auto-immunes, notamment pour les arthrithromatoïdes, du puce rétémateur disséminé, avec des symptômes digestifs, rénales, musculaires, neurologiques.

Il atteint le plus souvent la femme entre 40 et 60 ans. Le diagnostic est établi par la biopsie d'une glande salivaire accessoire, qui va montrer les dépôts immunologiques au niveau du tissu salivaire. Le traitement est souvent décevant.

Il fait appel à l'immunothérapie, aux psychothérapies, aux larmes et à la salive artificielle, et aussi à l'ogogue. L'évolution peut se faire vers un lymphome, qu'il faudra évoquer devant une évolution tumorale paroxysdienne. On a aussi d'autres scialadénoses qui peuvent se manifester par un syndrome sec, notamment les atteintes endocriniennes, diabète, hypothyroïdie, métabolique, cirrhose, alcoolisme par carence prosthétique, médicamenteuse par les antidépresseurs, fénotiennes vides et les herpines.

A côté des syndromes secs, on a les parotidomégalias essentielles. Ce sont les grosses parotides sans symptômes et sans anomalies histologiques. Elles sont d'origine familiale ou géographique.

Elles se rencontrent aussi chez les obèses, les diabétiques, les mangeurs excessifs de pain, les goûteurs et les cirrhotiques. Elles sont dues à l'hyperfonctionnement de la glande, jouant le rôle démonctoire. A côté de cette pathologie non inflammatoire, on a la pathologie inflammatoire, qui peut elle aussi être unio-bilatérale.

Pathologie des glandes salivaires principales, inflammatoires ou bilatérales, on a l'infection bactérienne cialite. La cialadénite litiasique se sera infectée. C'est l'apanage de la glande submandibulaire.

C'est une litiage au niveau de la glande submandibulaire qui va entraîner par obstruction une colique salivaire. On a une douleur au niveau de la région submandibulaire qui est accompagnée d'une hernie submandibulaire. Cette colique et cette hernie sont arrêtées par les repas.

Elle peut aussi se compliquer d'abcès du plancher buccal. La radiographie maxillaire défilée, surtout l'échographie, permet le diagnostic, surtout quand le calcul est radio-opaque. Le cialoscane, s'il s'en pratiquait, montrerait un blocage au niveau du calcul.

C'est une pathologie obstructive qui va évoluer vers une infection. Ça va donner une cialadénite litiasique se réinfecter. C'est une pathologie qui est unilatérale.

Le traitement en général est un traitement médical. Lorsqu'il y a des récives, on peut toujours faire une extraction du calcul s'il est obstructif et s'il est placé sur la patiente sinon on terminera par une exérèse complète de la glande, une submondibulectomie. Comme vous le voyez sur cet arbre de cialogramme, la flèche montre une obstruction du canal excréteur par un obstacle type litiasique.

On voit une amputation sur la continuité de l'opacité du canal excréteur. La parotide aiguë microbienne, c'est une pathologie qui atteint surtout le sujet âgé. En période post-opératoire, il y a une déshydratation, donc manque d'excrétion salivaire.

Par phénomène rétrograde, il y a pellulation microbienne dans la cavité buccale qui remonte par voie rétrograde au niveau du canal excréteur de la glande salivaire. Ça va entraîner une douleur, une fièvre. Rapidement, le patient fait un sepsis sévère.

Il peut même évoluer vers un choc septique. Cette pathologie est favorisée par une cause locale, notamment l'infection dentaire, la stomatite, d'où l'intérêt d'une bonne hygiène buccale chez un patient qui est hospitalisé en réanimation, intubé, pour éviter ces infections rétrogrades. Il existe un gonflement rétromandibulaire en général unilatéral, soulevant le lobe et l'oreille.

La peau est inflammatoire. L'orifice du sténant est rouge, avec à la pression un écoulement purulent, favorisé par la pression. De la région parotidienne.

L'évolution est favorable sous antibiotiques anti-inflammatoires et éventuelle réhydratation. Mais l'évolution peut se faire vers des micro-abcès qui vont signer la chronicité, avec sclérose glandulaire. La parotidite chronique non spécifique, elle est rare, et sont dues à une infection caninaire ascendante dont le trouble initial est mal connu.

L'évolution est récidivante. L'infection peut guérir sans séquelles, mais peut donner des parotides récidivantes chez l'enfant. Ou bien évoluer vers une hypertrophie sclérose.

Ce sont des glandes qui sont peu élastiques, qui deviennent dures et peu fonctionnelles. La tumefaction peut se voir. Elle est douloureuse à la mastication.

La parotide est hypertrophiée et douloureuse à la palpation. La scialographie peut montrer des images typiques avec dilatation des canaux et images multiples en grains de plan. La parotidectomie n'est indiquée qu'exceptionnellement dans les cas sévères associés à des malformations canalières.

Méga, dolico, sténom. La digestion d'une aire faciale est difficile. On fait des processus inflammatoires récurrents qui vont aboutir à un tissu inflammatoire et de la sclérose.

C'est ça l'image du fameux pommier japonais qui correspond à des dilatations des canaux excréteurs. A côté de cette pathologie inflammatoire unilatérale, il y a la pathologie inflammatoire bilatérale qui correspond aux infections virales. Les infections virales, comme vous l'avez déjà vu en pathologie pédiatrique, toutes les infections virales qui vont toucher l'enfant vont entraîner une hypertrophie des glandes de parotides.

Cette glande, par leur richesse lymphoïde, va réagir à l'agression virale et va s'hypertrophier. Cette pathologie, dominée par la parotidite aurélienne, les oréans, est aisément reconnue par la notion d'épidémicité, de contagion, l'aspect de l'œdème cutané gélatineux, la bilatérité, l'atteinte des glandes sous-mandibulaires peut se voir aussi. Le dosage biologique éventuel de l'amylasémie est augmenté.

Et il est rare de voir des parotidites auréliennes depuis la généralisation de la vaccination. C'est vraiment un accident qui devient assez rare. Mais il y a d'autres parotidites virales, notamment les parotides Akosaki virus.

Et on peut aussi voir même des parotidites à HIV. On ne peut pas conclure ce cours sans parler des diagnostics différentiels de ces pathologies des glandes salivaires qui est autant plus polymorphe que la pathologie salivaire elle-même. Ce qui va être à l'origine de causes d'erreurs dans les diagnostics, notamment par la richesse d'éléments anatomiques dans cette région.

Donc il est difficile de différencier une adénopathie cervico-faciale d'une tumeur de la parotide. A savoir que dans la parotide il y a des ganglions. Donc l'adénopathie cervico-faciale reste le diagnostic différentiel le plus important de ces pathologies salivaires.

L'actinomyose cervico-faciale qui est une lésion inflammatoire cutanée-sous-cutanée et qui est plus fréquente chez l'enfant. Les autres causes de tumeurs para-pharyngées, les para-ganglions, les tumeurs nerveuses, les tumeurs macétérines. La mastoïde à évolution cervicale.

La mastoïde est assez développée et donc elle donne aussi un diagnostic différentiel. Lorsqu'on touche la prophystiloïde, on a l'impression de toucher une tumeur, mais c'est surtout la prophystiloïde qui pointe au niveau de la région submandibulaire. La mastoïde à évolution cervicale.

La fistule de la première fente. La forme qui signifie qu'un trait parasidien. La palpation de la

prophyse transverse de l'atlas.

Donc c'est pour dire qu'il faudra différencier ce qui n'est pas glande salivaire, toutes les pathologies qui ne sont pas d'origine glande salivaire, mais aussi il faudra différencier toutes les pathologies qui ne sont pas dans la région de la glande salivaire. À l'intérieur de la glande et à l'extérieur de la glande, on a des diagnostics différentiels. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une pathologie qui est très polymorphe, mais quand même qui garde certains signes cliniques qui vont nous orienter dans notre diagnostic.

Mais le plus important, c'est que devant toute tumefaction unilatérale, d'évolution lente, non inflammatoire, isolée, il faudra penser dans la parotide à un adhérent pléomorphe. Lorsqu'elle est associée à une paralysie faciale, une douleur ou une adénopathie, il faudra penser à une tumeur maligne. Et que le diagnostic histologique ne se fera que par une tumeur exploratrice.

Donc retenez que même quand on fait le diagnostic de la tumefaction, le seul diagnostic positif ne sera valable, si c'est un processus tumoral isolé, que par examen histologique. Donc il faut apprendre par cœur que une tumefaction parotidienne unilatérale, d'évolution lente, non inflammatoire, quand elle est isolée, il faudra évoquer en premier un adhérent pléomorphe. Lorsqu'elle est associée à une paralysie faciale ou une adénopathie, il faudra évoquer une tumeur maligne.

Et que le diagnostic histologique est assuré par la parotide atonique exploratrice et celui qui donne le diagnostic positif. Donc je vous remercie et à la prochaine.